جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هند حسين عبده سالم
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الجماليه **العنوان :** .....
رقم البطاقة : 28906250101125 **رقم التليفون :** 01159035123 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 25-06-1989 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هند حسين عبده سالم
National ID: 28906250101125

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

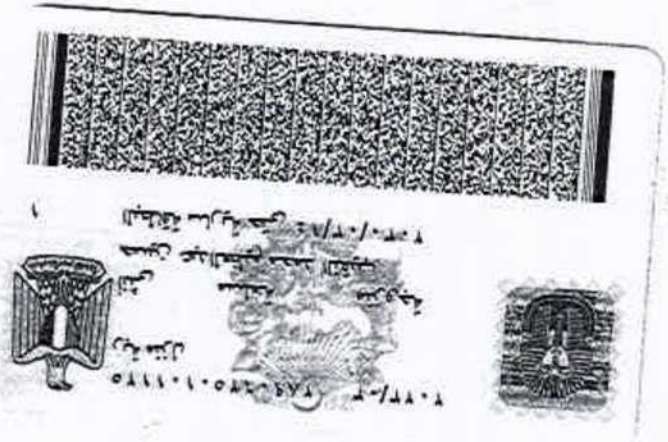
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / هند حسين عبده سالم	Request No.	: 13006441
Patient No.	: 28906250101125	Request Date	: 07/10/2024
Path No.	: 3797/24	Verification Date	: 20/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 35 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Up-Front

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:
* Procedure: Left MRM measured 15x13.5x3.5 cm with covering skin ellipse measured 13.5x7 cm.
* Tumor extent: An ill defined retroareolar greyish white ruberry tumor bed site.
* Size: 5.8x 5.8 x2 cm.
* Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
* Distance from margins: 1 cm from the skin and 1.3 cm away from deep margin.
* Lymph nodes number and size: Axilla measured 5.5x4x1.5 cm, entangling 14 L.Ns up to 1.5x1x0.7 cm.
* Rest of the breast showed scattered ruberry grayish white areas.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+3+2) Grade III.
* Ductal carcinoma in situ: Extensive DCIS.
* Skin involvement: Paget's disease of the nipple.
* Lymph node involvement: Negative (0/14).
* Resection Margins: Deep margin showed DCIS.

Diagnosis:
Left breast cancer , MRM specimen:
* Invasive duct carcinoma G III with Extensive DCIS.
* Paget's disease of the nipple.
* Lymph nodes were Negative (0/14).

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: هند حسين عبده **MR. :** 4688	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with premenopausal left-breast invasive ductal carcinoma, clinical stage T2, with an upfront mastectomy performed in 2024. Following surgery, the patient received adjuvant chemotherapy and postoperative radiation therapy and is currently maintained on hormonal treatment.

The patient is receiving FEMARA, CALCIUM ONE ALPHA, and ZOLADEX 10.8. A transvaginal ultrasound performed on 29/3/2026 demonstrated a free endometrial line measuring 3 mm.

The patient continues management of breast cancer with an aromatase inhibitor (AI) and ZOLADEX, with ZOLADEX administered today.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد

يعتمد ,

Patient Name	:الأستاذه / هند حسين عبده سالم	Request No.	: 13006441
Patient No.	:28906250101125	Request Date	: 07/10/2024
Path No.	:3797/24	Verification Date	: 20/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	:35 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

* Deep margin showed DCIS.
- Stage: pT3, pN0

Signature
Dr. Rana Fathy.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / هند حسين عبده سالم	Request No.	: 13001556
Patient No.	: 28906250101125	Request Date	: 14/08/2024
Path No.	: 2928/24	Verification Date	: 25/08/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 35 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast 10 O'clock mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 13/08/2024.

Gross Examination:
- Multiple grayish white tissue cores up to 1.3 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: Focally detected.
* Perineural invasion: Not detected.
* Angioinvasion: Not detected.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II, With focal DCIS.
For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Gamal Abd-El-Aty.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hend Hussein Abdou Salem	Date : 02/09/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 35 Year(s)
Medical ID: 2975/2024	Pat. ID: 40733

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

- **Reported case of left breast cancer.**

I Chest:-

- Enlarged bilateral axillary lymph nodes are seen level I, largest on the right side measuring about 2 x 2.3 cm, for sono-mammographic correlation.
- Clear both lung fields.
- No pulmonary nodules, masses, consolidation, cavitation or collapse.
- No hilar or mediastinal pathologically enlarged lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged in size with homogenous CT texture. No definte focal lesions (on non contrast base) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen. Small spenule is also noted.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal non enhanced CT appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bulky uterus showing homogeneous myometrium with no definite focal lesions
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

*Scanned skeleton:

Small well defined lytic lesion with faint sclerotic margin is seen at D7 vertebra

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hend Hussein Abdou Salem	Date : 02/09/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 35 Year(s)
Medical ID: 2975/2024	Pat. ID: 40733

Opinion:

- **Known case of cancer breast with no definite chest, abdominopelvic metastatic deposits**
- **Small D7 vertebral body osseous lesion, worrisome for metastatic deposit, for further bone scan assessment**

Dr. Shaimaa Khaled, MSc.
Signature Dr Ibrahim Abo El Magd
08/09/2024 11:54 ص

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name: Hend Hussien Abdo. Date: 11/9/2024

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information: skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- Degenerative changes are noticed over dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes of big joints.
- No definite hot spot that accounts for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Both kidneys are seen.

Conclusion:

The surveyed skeleton is free of any active osseous lesions.

Thanks for referral

1- Nuclear Medicine Unit

2- DR . Sherin Mahdy, MD

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	الأستاذه / هند حسين عبده سالم	Request No.	13001556
Patient No.	28906250101125	Request Date	14/08/2024
Path No.	2928/24	Verification Date	27/08/2024
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - مبادره
Age	35 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Comment: Although Her2 is Negative, Such cases (Score 1+) are predictive of response to Her2-Ab drug conjugates (ADCS) according to latest 2023 ASCO-CAP guidelines.

Signature
Dr. Walaa Ghonim.
Dr. Sagda Elkady.

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	: الأستاذه / هند حسين عبده سالم	Request No.	: 13001556
Patient No.	: 28906250101125	Request Date	: 14/08/2024
Path No.	: 2928/24	Verification Date	: 27/08/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 35 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 13/8/2024.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67: 20% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II with focal DCIS.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: (score 1+).
- Ki67: Positive in 20% of tumor cells.

* Scoring system: "ER, PR"

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]